

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

Eva
EVANIR NUNES FERREIRA

IDADE: 60 PESO: 60 ALTURA: 155 PROFISSÃO: Psicoterapeuta

SINTOMAS: Dor de cabeça / mms e edema / Fadiga mm.
sente uma nevia p/ pensar

QUEIXAS: Despertares.

MEDICAMENTOS: Magnésio / Sintroid 100.

MÉDICO: Dr. Luciano

MARCAPASSO: () S ☒ AN / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ AN

EXERCÍCIO FÍSICO: Todos os dias (musc. / alongamento / yoga)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: - JANTAR: 20

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 07/08hr

COCHILHO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N RaroFUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 0X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: -

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 68,9 SPO2: 81%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinite / Deviação (D) / Desp. → 27,7 efv
Dor no tornozelo (E). mPI = 10,1 efv

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: -

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 C/ CPAP: - PRESSÃO NO EXAME: -

14/02 Avaliação - CPAP autom. Gua

25 P = 6-8 cmH₂O (P = 6,4) não teve dor de cabeça.

21/02 IAH = 1,5 efv

25 m. de uso: 8h 14'

Fuga = 0,0 efv.

07/03 P = 6,4 cmH₂O

25 IAH = 1,3 efv

m. de uso: 7h 5'

Fuga = 1,5 l/m

14/04 P = 6,4 cmH₂O

25 IAH = 1,2 efv

m. de uso: 7h 8'

Fuga = 4,3 l/min

Gua.



Clínica

DR. ALBERTO REMESAR
Psiquiatria do bem-estar

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Psiquiatria pela UFRJ
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP
Medicina do Sono pela Soc. Brasileira do Sono
CRM 69.730 - RQE 40.178

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Evanir Nunes Ferreira

EXAME nº: 5650

SOLICITADO POR: Dr. José Alberto Xavier da Cunha

DATA: 01/11/2024

IDADE: 59 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h14min e concluído às 06h01min. A latência para o sono foi de 25 minutos e a latência para o estágio REM, de 219 minutos. O tempo total de sono foi de 359,5 minutos (05h59min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 77,6%. A distribuição do sono registrado mostrou 17,7% de estágio 1, 58,3% de estágio 2, 6,7% de estágio 3 e 17,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 78,5 minutos em vigília, ocorreram 166 microdespertares (índice: 27,7/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 4,7/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 68,9/hora, sendo 9 apneia/hora e 59,9 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 79,1/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 93% e a mínima de 81%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (68,9/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (79,1/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 67 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 25 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (219 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 77,6%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 27,7/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) durante o estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (17,7%; normal: 8-10%) e 2 (58,3%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (6,7%; normal: 10-12%) e REM (17,4%; normal: 20%).

O índice de movimentos periódicos de membros (4,7/hora; normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 2 (normal até 9; máxima: 24).

Avenida Dr. João Guilhermino, 474 - salas 51 e 52
Edifício Office Tower - Centro - São José dos Campos
Tel: (12) 3913-2162 / (12) 3941-2449 / (12) 99622-8008

Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69730 - RQE 40178

Nome: EVANIR NUNES FERREIRA
Data de Nascimento: 14-12-1964
IMC: 24,97
Sexo: Feminino
Data do exame: 01-11-2022

Peso: 60 kg
Altura: 1,55 m
Médico: DR.A. LILIAN CHRYSTIANE G
MARSON
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 01-11-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 579,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 71,5 e 101,5 minutos. O tempo total de sono foi de 439,0 min, eficiência de 75,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 55,8%; estágio N3: 17,7%; sono REM: 24,6%. O índice de despertares foi de 4,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 2,6/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 19 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 75 bpm e NREM de 53 - 77 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (2), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 2,6/hora;
4. não houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=90%);
5. latência para o sono aumentada;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (10,1/hora);
8. presença de atividade em EMG de queixo;
9. registro de ronco durante o sono.

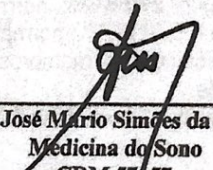
Exame evidenciando roncopia primária. Presença de bruxismo.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Dr. Luciano Rotella

Título de Especialista em
Otorrinolaringologia.
ABORL - CCF

Especialista em Medicina
e Biologia do Sono - AMB

Graduação médica - UNIFESP
Escola Paulista de Medicina.

Emilio Ferreira

Solicito para tratamento de SAOS

CID: G47.3

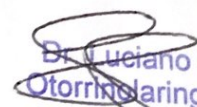
() CPAP com pressão titulada de _____ cm H₂O

() BIPAP com pressão insp de _____ cm H₂O e exp
_____ cm H₂O

(☒) CPAP com pressão sugerida de 8 cm H₂O e
relatório após 20 dias de uso

 (12) 3923-4000

 Avenida 9 de Julho, 765,
1º Andar, Ed. Apollo Center,
São José dos Campos


Dr. Luciano Rotella
Otorrinolaringologista
CRM 111556

www.drlucianorotella.com